



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos
Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

Hemograma com Contagem de Plaquetas

(Material: Sangue Total)

Série Vermelha

(Método: Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Eritrócitos	6,05	10 ⁶ /μ L	4,50 a 5,50	10 ⁶ /μ L
Hemoglobina	17,7	g/dL	13,0 a 17,0	g/dL
Hematócrito	50,8	%	40,0 a 50,0	%
VCM	83,9	fL	83,0 a 101,0	fL
HCM	29,3	pg	27,0 a 32,0	pg
CHCM	34,8	g/dL	31,0 a 35,0	g/dL
RDW	13,2	%	11,6 a 14,0	%

Série Branca

(Método: Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

	%	/μL		%		/μL
Leucócitos	100	6.660	100	%	4.000 a 10.000	/μL
Neutrófilos	64,4	4.289	40,0 a 80,0	%	1.800 a 7.800	/μL
Eosinófilos	3,2	213	1,0 a 6,0	%	20 a 500	/μL
Basófilos	0,4	27	0,0 a 2,0	%	20 a 100	/μL
Linfócitos	24,0	1.598	20,0 a 40,0	%	1.000 a 3.000	/μL
Monócitos	8,0	533	2,0 a 10,0	%	200 a 1.000	/μL

Diferencial leucocitário liberado por automação, não sendo observados critérios de imaturidade na série neutrofílica para realização de leitura manual da lâmina.

Contagem de Plaquetas

(Método: Impedância)

Contagem de Plaquetas	197.000	/μL	150.000 a 450.000	/μL
VPM	13,5	fL	8,3 a 12,5	fL

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis, 12ed, 2017.

Assinado eletronicamente por Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (13/09/2025 15:13 BRT)
74b4df3379eddd34fd2086a0e8e890c55794e831b334d2df9f0345ec03a2e714

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos
Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)
Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

Hemoglobina Glicada (HbA1c)

(Material: Sangue Total)

**Hemoglobina Glicada -
HbA1c**

5,3 %

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Imunoturbidimetria)

Gráfico de Histórico

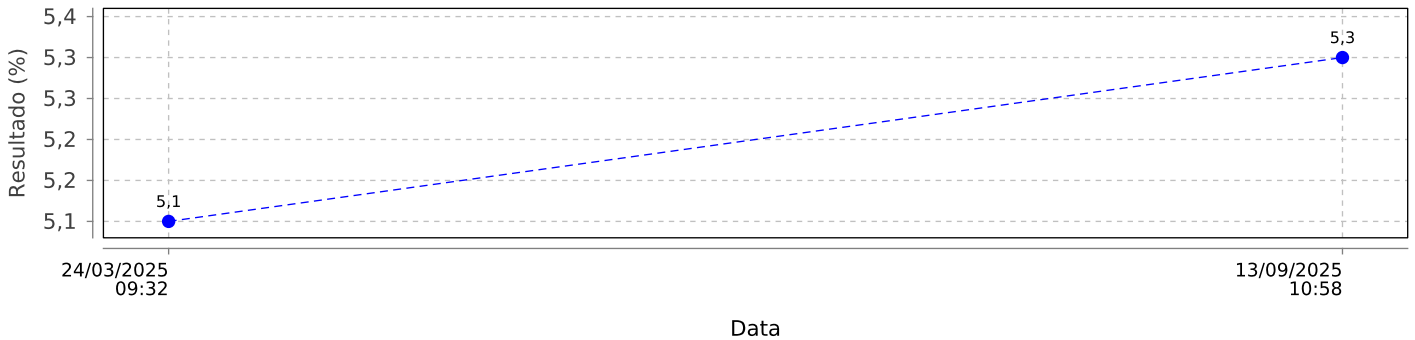


Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%
Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4 %
Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

**Glicose Média Estimada
(GME)**

105 mg/dL

(Método: Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111–S125.

Assinado eletronicamente por Suzana Anastacia de Lima Barreto CRF-RJ 12477 (14/09/2025 00:47 BRT)

bbe164db1d76cead373c8dfa6f40762a3b8faff70c763705a58ae0825b8d45c6

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Sheila Vasques Leandro

Coordenador: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469

Data da Geração: 23/09/2025 19:03:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 52-0105890-8

Laboratório registrado no CRM/RJ: Sob o número 0111212-0

7700.0173.1542
PG 2 de 28

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

Homocisteína

(Material: Soro)

15,1 µmol/L

8,0 - 19,1 µmol/L

(Método: Quimioluminescência)

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 19/05/2025.

Intervalo de Referência estabelecido por método indireto em 2.459 indivíduos adultos atendidos na Dasa, particionados por sexo.

Nota: Diversos medicamentos podem interagir com o metabolismo da homocisteína aumentando significativamente seus níveis.

Referência Bibliográfica:

Drugs Affecting Homocysteine Metabolism: Impact on Cardiovascular Risk. Desouza C, Keebler M, McNamara DB, Fonseca V. Drugs. 2002;62(4):605-16. doi:10.2165/00003495-200262040-00005.

Assinado eletronicamente por Daniel de Moraes Brito CRBIO-RJ 111837/02 (15/09/2025 01:17 BRT)
f2bde21829becaf0788b899e48b7e61ee93d8f9f5bc5948b640a4978e2e34b0f**Apolipoproteína "B"**

(Material: Soro)

68 mg/dL

55 a 140 mg/dL

(Método: Nefelometria)

Assinado eletronicamente por Renata Goncalves - CRBIO-RJ 24943/02 (13/09/2025 21:44 BRT)

5a4e1703359593ec4e97dc1b3c0387e120e97f620a988daa281d5b96b1aea0fb

**Vitamina B-12,
Dosagem**

(Material: Soro)

753 pg/mL

245 a 985 pg/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Intervalo de referência estabelecido por método indireto, com base na análise de 6.224 indivíduos avaliados em estudo interno.

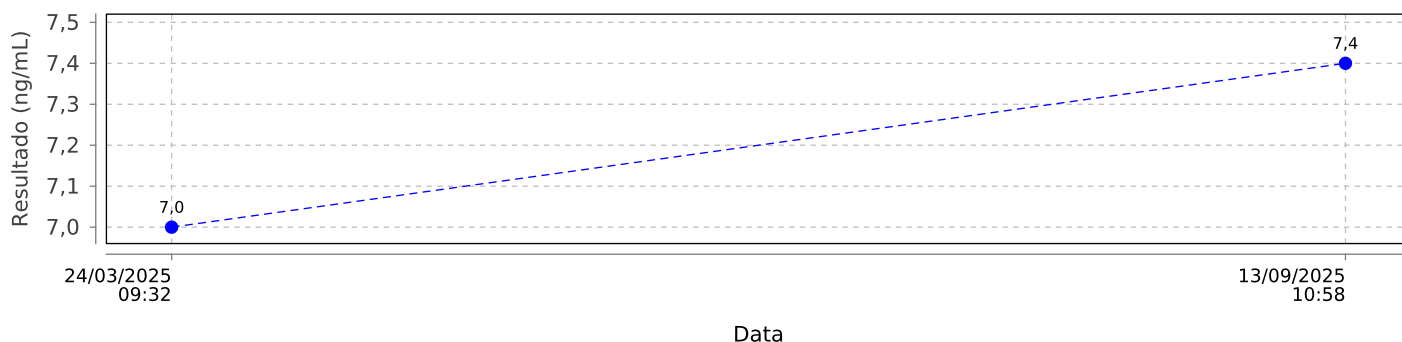
Assinado eletronicamente por Beatriz Cabral Abreu Grijo CRBM - RJ 57204 (14/09/2025 05:22 BRT)
b7204aa33c11b56443cd2e7e3f82bc49e1d0b7fc7ea8f62c0e16ee2daabac4d6**Prolactina**

(Material: Soro)

7,4 ng/mL

4,04 a 15,20 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

Sulfato de Dehidroepiandrosterona

(Material: Soro)

213,0 µg/dL

160,0 a 449,0 µg/dL

(Método: Eletroquimioluminescência)

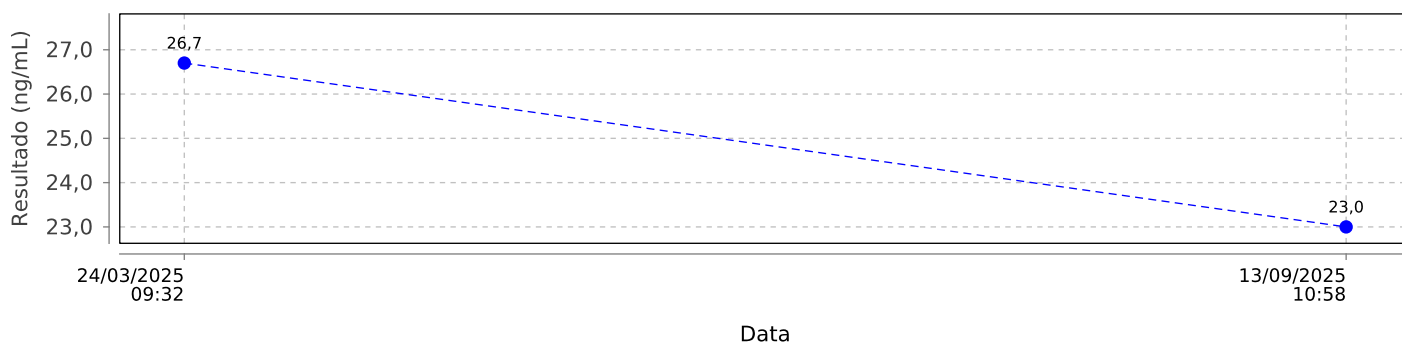
25 OH Vitamina D

(Material: Soro)

23,0 ng/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

Mudança de Metodologia a partir de 21/11/2023.

Tabela de Referência - 25 OH Vitamina D

População saudável abaixo de 60 anos: Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

***São considerados grupos de risco para hipovitaminose D:** Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes).

Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Bibliografia: Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em 18/12/2017.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

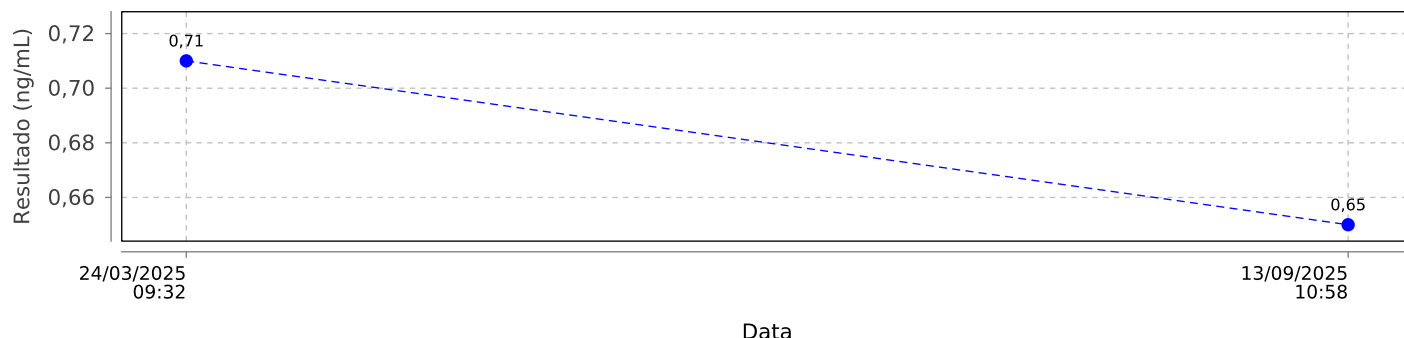
PSA Total

(Material: Soro)

0,65 ng/mL

Inferior a 4,00 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

- Exame executado no equipamento Cobas, do fabricante Roche, pelo método de Eletroquimioluminescência.

- Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico específico.

Notas:

1. Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia de próstata.

2. Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.

3. O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores do PSA Total se situam entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa, a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer 2017.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

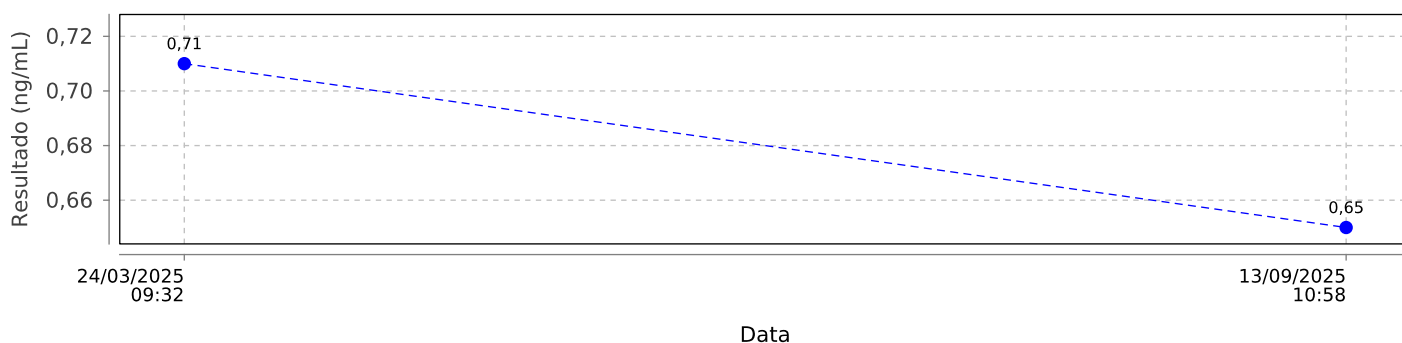
PSA - Antígeno Prostático Específico Total e Livre

(Material: Soro)

PSA Total**0,65** ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Inferior a 4,00 ng/mL

Gráfico de Histórico**PSA Livre****0,28** ng/mL

Vide Notas

- Exame executado no equipamento Cobas, do fabricante Roche, pelo método de Eletroquimioluminescência.
- Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico específico.

Observação:

- Não há intervalos de referência estabelecidos na literatura para PSA Livre isolado.
- Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.
- O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores de PSA Total situam-se entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa, a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da Relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guideline on Prostate Cancer, 2023.

Notas:

1. Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia de próstata.
2. Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.
3. O cálculo da relação PSA Livre/PSA Total só tem significado clínico quando os valores do PSA Total se situam entre 4,0 e 10,0 ng/mL. Fora desta faixa, a relação não é calculada pelo laboratório.

Referência da relação PSA Livre/PSA Total: European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer 2017.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

Assinado eletronicamente por Beatriz Cabral Abreu Grijo CRBM - RJ 57204 (14/09/2025 05:21 BRT)

77d0a8bb59e5e4aed4dec6122941c800e9b90b45f379109284a453c6d55c5455

Exame de Urina de Rotina

(Material: Urina - jato médio)

(Método: Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo e Microscopia)

Densidade	1.014		1.010 a 1.025
pH	5,0		5,0 a 7,0
Cor	Amarelo Claro		Amarelo Claro ao Amarelo
Aspecto	Ligeiramente Turva		Límpido a Ligeiramente Turva
Proteína	Ausente		Ausente
Glicose	Ausente		Ausente
Corpos Cetônicos, Pesquisa	Ausente		Ausente
Bilirrubina	Ausente		Ausente
Nitrito	Negativo		Negativo
Hemoglobina	Ausente		Ausente
Leucócitos	1	µL	0 a 27 µL
Hemácias	0	µL	Masculino: 0 a 16 µL Feminino: 0 a 27 µL
Cilindros	Ausente		Ausente
Celulas Epiteliais	1	µL	0 a 22 µL
Cristais	Ausente		Ausente

Métodos:

Elementos Anormais - Leitura Automatizada de Tiras Reagentes.

Sedimento - Automatizado por Citometria de Fluxo por imagem e Microscopia Optica.

Assinado eletronicamente por Mario da Cruz Sousa CRBIO-RJ 096476/02 (13/09/2025 14:48 BRT)

3dec927651328ce64e19ea7220004febaacb596c030b1ef17910644582e17ab8

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304



Coordenador: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 10:58 BRT

Cultura de Urina Jato Médio

(Material: Urina - jato médio)

(Método: Cultura quantitativa cinética e/ou convencional com identificação e antibiograma automatizados)

Cultura de Urina

Resultado:

Negativo

Negativo

Assinado eletronicamente por Adriana Lucia Pires Ferreira CRBIO-RJ 21109 (15/09/2025 12:32 BRT)

71b051b183d2fb54ecae6878aca231a9cfa0f70c004abb533ab44eb1fe1757a5

Responsável: Dr. Alberto Chebabo - CRM:52-47774-3



Coordenador: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469

Locais de execução dos exames:

- DASA - Rua Xavier Pinheiro, 439 Quadra 29 - Pq. Duque de Caxias CNES:7402074 - Duque de Caxias, RJ: 25 OH Vitamina D, Apolipoproteína "B", Cultura de Urina Jato Médio, Exame de Urina de Rotina, Hemoglobina Glicada (HbA1c), Hemograma com Contagem de Plaquetas, Homocisteína, PSA - Antígeno Prostático Específico Total e Livre, PSA Total, Prolactina, Sulfato de Dehidroepiandrosterona, Vitamina B-12, Dosagem

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

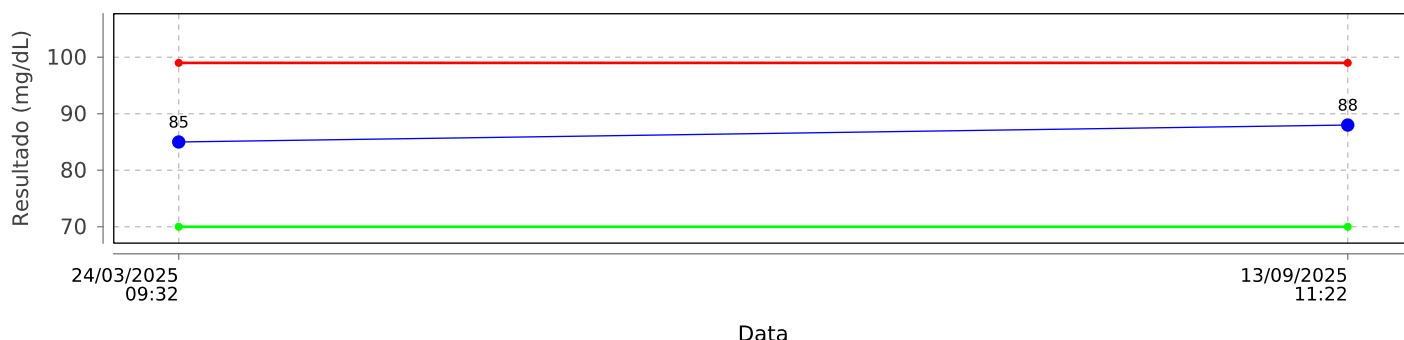
Glicose

(Material: Soro)

88 mg/dL

70 a 99 mg/dL

(Método: Hexoquinase)

Gráfico de Histórico**Referência Bibliográfica:**

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Valores sugeridos pela Associação Americana de Diabetes.

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:17 BRT)

808a3e1eaad33aa4472c47de2c5299cc1782ba6ca1bdf96b69d5c727fa196ced

Sódio

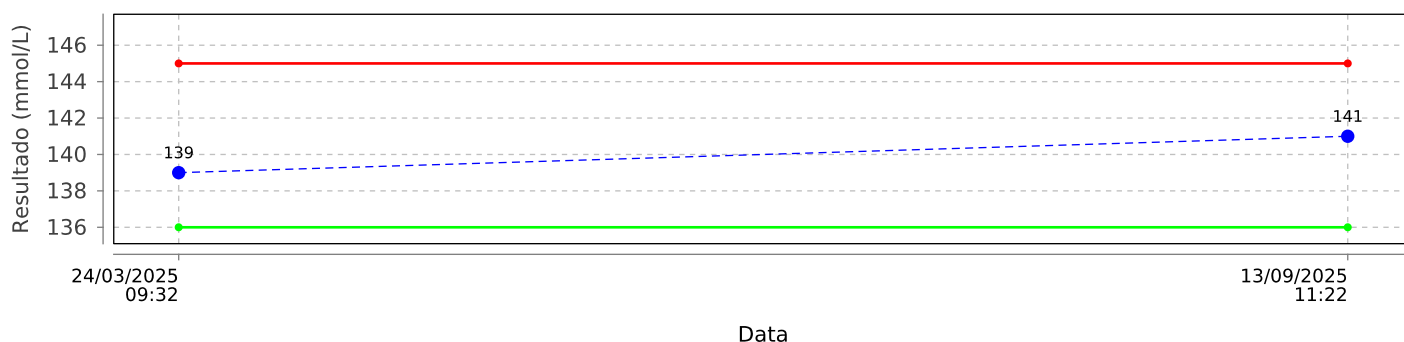
(Material: Soro)

141

mmol/L

136 a 145 mmol/L

(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

Gráfico de Histórico

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:35 BRT)

9eabe00abcda2a8f0a5910fbbb732c30893847285821025dd3e591ae389cecd5

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

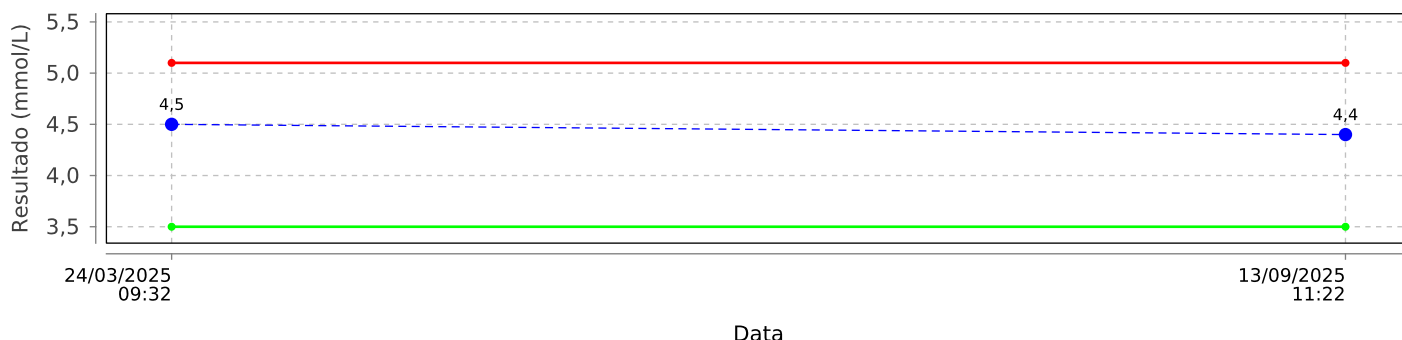
Potássio

(Material: Soro)

4,4 mmol/L

3,5 a 5,1 mmol/L

(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

Gráfico de Histórico**Referência bibliográfica:**

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 7th Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2015.

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:17 BRT)

a29c6f386130c6f5acade15212b88b99d24288244b0f0286c62d9d4c9e7734ae

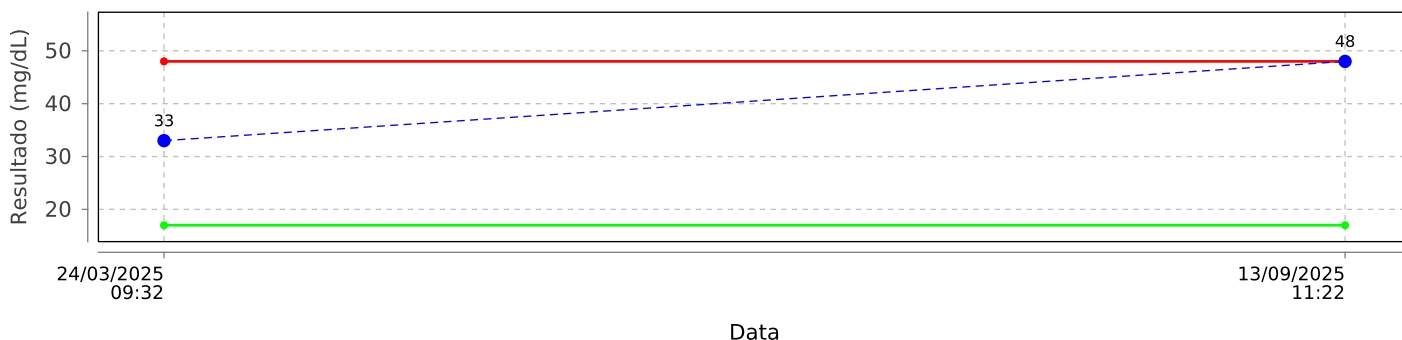
Uréia

(Material: Soro)

48 mg/dL

17 a 48 mg/dL

(Método: Cinético)

Gráfico de Histórico

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 16:46 BRT)

e6cdd73981938f7724b8d37de2de33f629821533548e4911cd05c8cbf855dd05

7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

HDL - Colesterol

56 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico

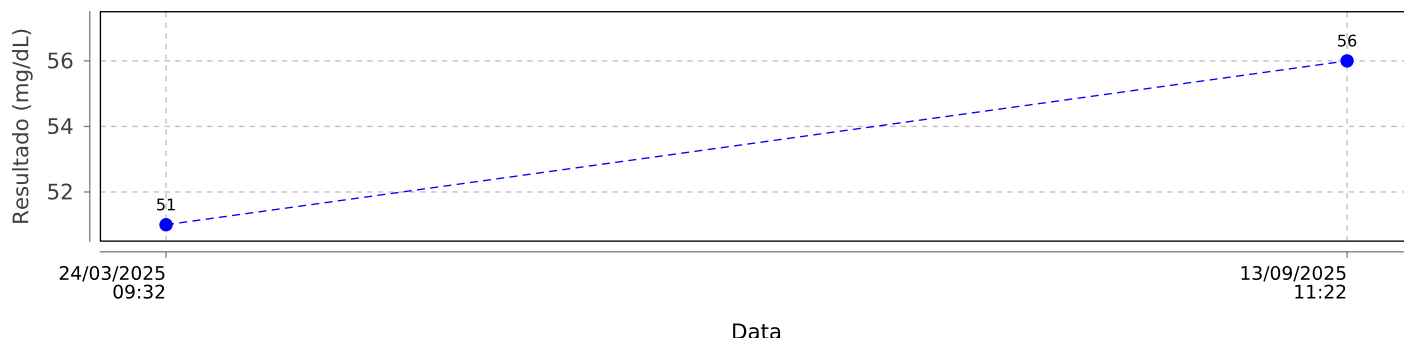


Tabela de Referência - HDL - Colesterol

Com jejum: Superior a 40 mg/dL
Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:16 BRT)
3f1e271312003eac20024b6f4dee8870d6ea90efc6ea42d1b697e2155ff09af3

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Insulina com Índice HOMA

(Material: Soro)

Insulina**4,0** µUI/mL

2,5 a 13,1 µUI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Cálculo do Índice de HOMA**HOMA-IR****0,87**

Inferior a 2,70

(Método: Cálculo)

Intervalo de referência da Insulina estabelecido por método indireto em 47.575 indivíduos atendidos nos laboratórios da DASA.

1. O Índice HOMA - Homeostatic Model Assessment - é obtido pela fórmula proposta por Matthews e col. permitindo através da determinação de glicose e insulina de jejum estimar respectivamente a resistência insulínica. Estes índices podem variar de acordo com a população estudada, o índice de massa corporal, apresentação de anticorpos anti-insulina, o uso de alguns medicamentos e condições fisiológicas como puberdade, gestação e senilidade.

2. O cálculo HOMA é realizado diante de glicose sérica entre 70 e 250 mg/dL e insulina sérica entre 2 e 40 µUI/mL.

3. O uso HOMA beta não apresenta boa correlação com índices de clamps glicêmicos para sua aplicabilidade na prática clínica. Sua utilização tem sido vinculada ao âmbito de pesquisas clínicas.

Referência Bibliográfica:

Geloneze B, Vasques AC, Stabe CF, Pareja JC, Rosado LE, Queiroz EC et al. HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in identifying insulin resistance and metabolic syndrome: Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS). Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(2):281-7

Assinado eletronicamente por Michel Trindade da Silva CRBIO-RJ 96.439/02-D (14/09/2025 18:48 BRT)

1f3d936a94b14afd538b2332da4ed6a8a123eb31a3a87dac78d58a249ad75064

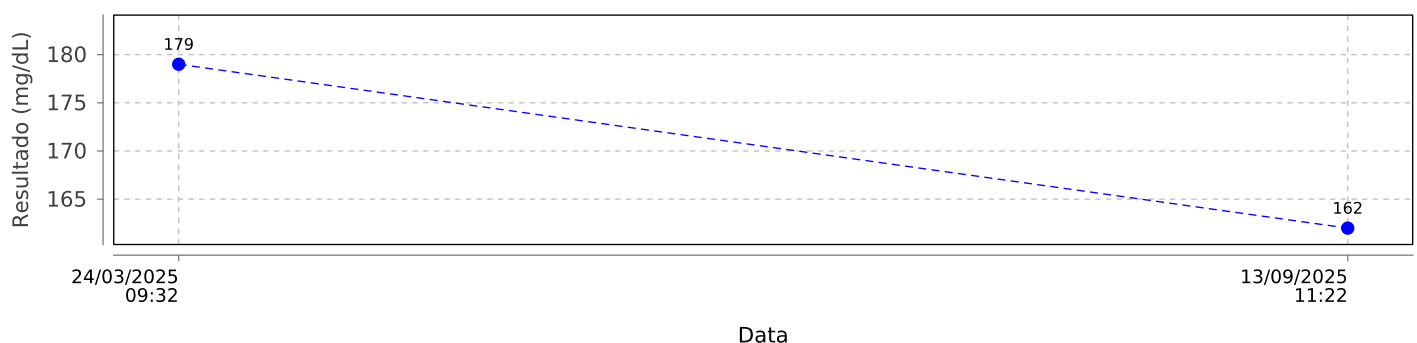
Colesterol Total

(Material: Soro)

162 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico**Tabela de Referência - Colesterol Total**

Com jejum: Inferior a 190 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

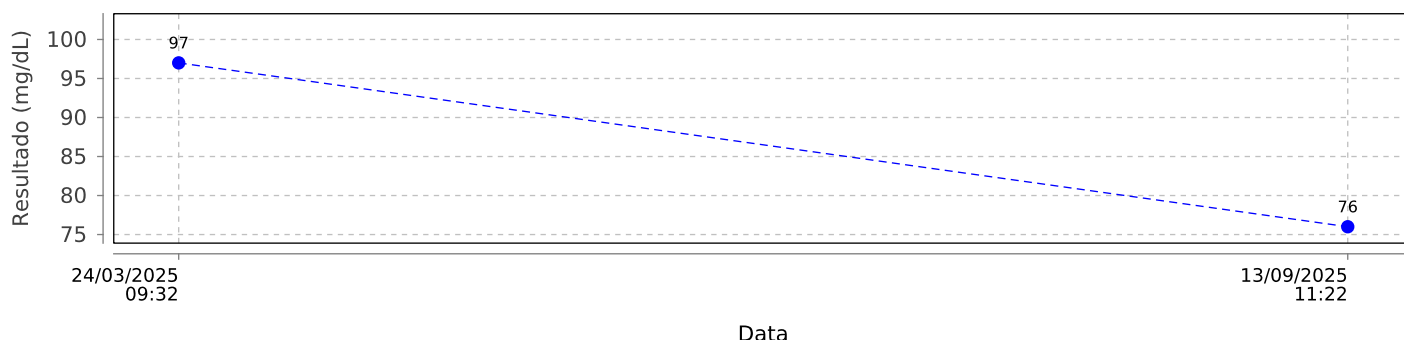
Triglicérides**76**

mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico**Nota:**

Resultados de triglicérides, em 3 coletas diferentes, superiores a 1.000 mg/dL em adultos com jejum de 12 horas e superiores a 880 mg/dL em crianças e adolescentes independentemente do jejum, sugerem Síndrome da Quilomicronemia Familiar.

Referência:

Izar et al. Posicionamento Brasileiro sobre Síndrome da Quilomicronemia Familiar - 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(4):e20230203.

Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum: Inferior a 150 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

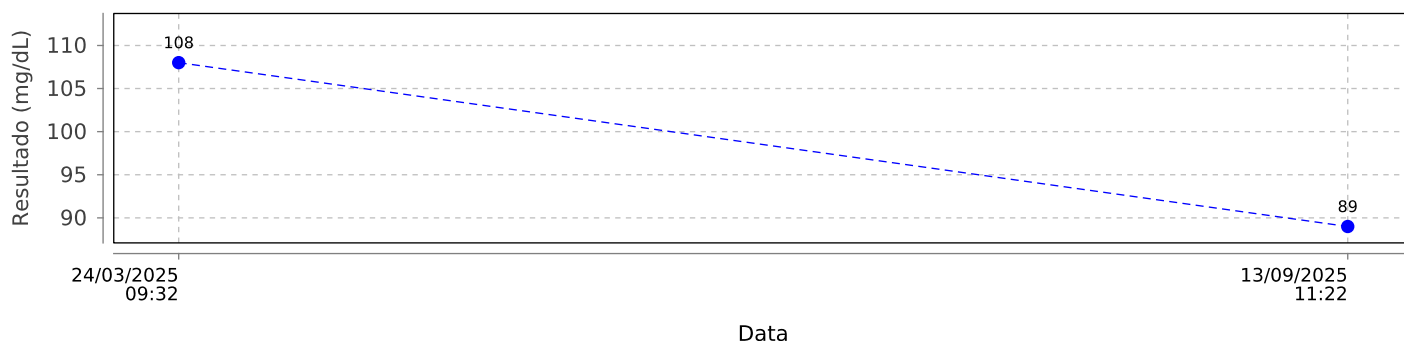
**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

**LDL - Colesterol
(calculado)****89** mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

Gráfico de Histórico**Tabela de Referência - LDL - Colesterol (calculado)**

Risco cardiovascular estimado e Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):
Muito Alto: Inferior a 50
Alto: Inferior a 70
Intermediário: Inferior a 100
Baixo: Inferior a 130

As frações LDL e VLDL são calculadas através da fórmula de Martin.¹ Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8."

A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

VLDL - Colesterol

17 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

Gráfico de Histórico

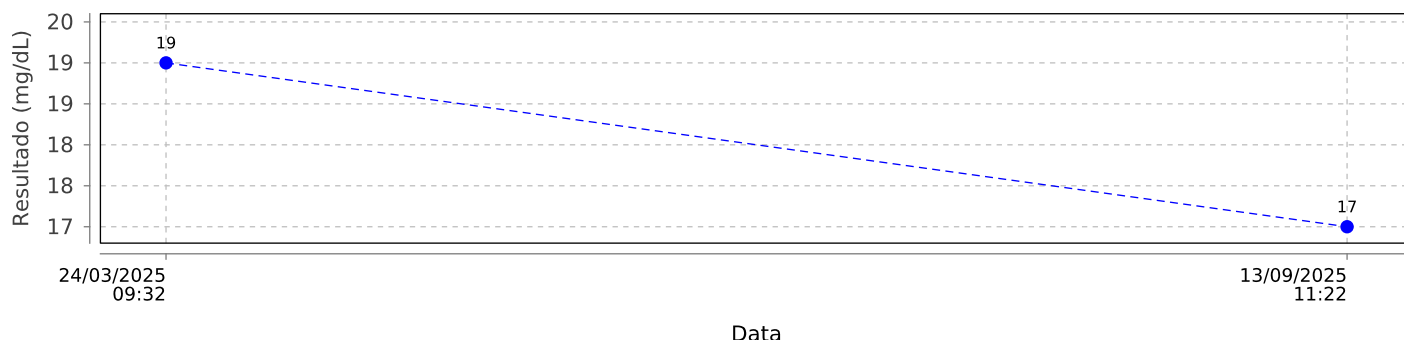


Tabela de Referência - VLDL - Colesterol

Não apresenta intervalo de referência definido.

Não HDL - Colesterol

106 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Não HDL - Colesterol

Risco cardiovascular estimado e Meta de NÃO HDL a ser alcançada (com ou sem jejum):
Muito Alto: Inferior a 80 mg/dL
Alto: Inferior a 100 mg/dL
Intermediário: Inferior a 130 mg/dL
Baixo: Inferior a 160 mg/dL

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:16 BRT)

f04394a0de2ed970500cc73068146ae8f87d4dcf63bf198e5a0058124464e979

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Ácido Úrico

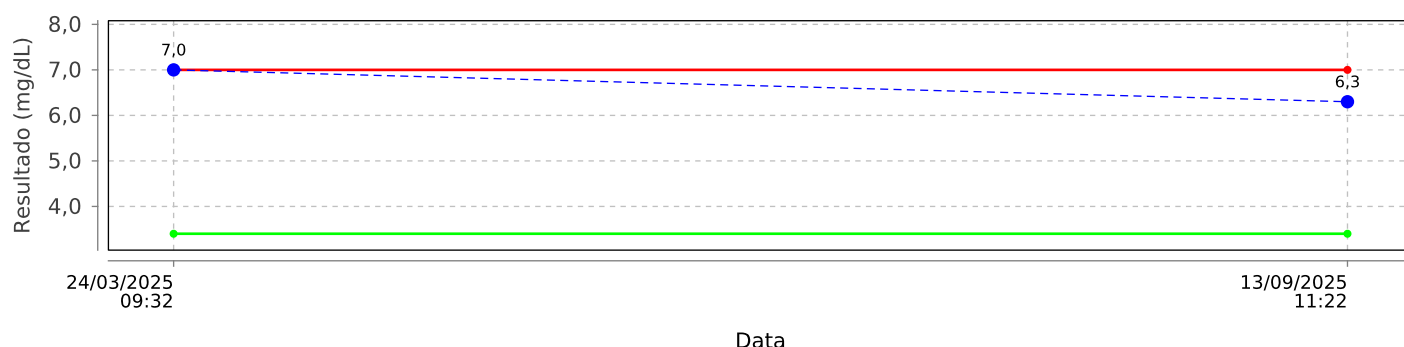
(Material: Soro)

6,3

mg/dL

3,4 a 7,0 mg/dL

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico

Nos pacientes em tratamento de gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico inferiores a 6 mg/dL.

Referência bibliográfica:

2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. John D. FitzGerald, Nicola Dalbeth, Ted Mikuls, Romina Brignardello-Petersen, Gordon Guyatt, Aryeh M. Abeles, Allan C. Gelber, Leslie R. Harrold, Dinesh Khanna, Charles King <https://doi.org/10.1002/acr.24180>

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:35 BRT)

29ed37422842bc6ed4cde3d26a98d654807b6364022328bf1e79112b49662536

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

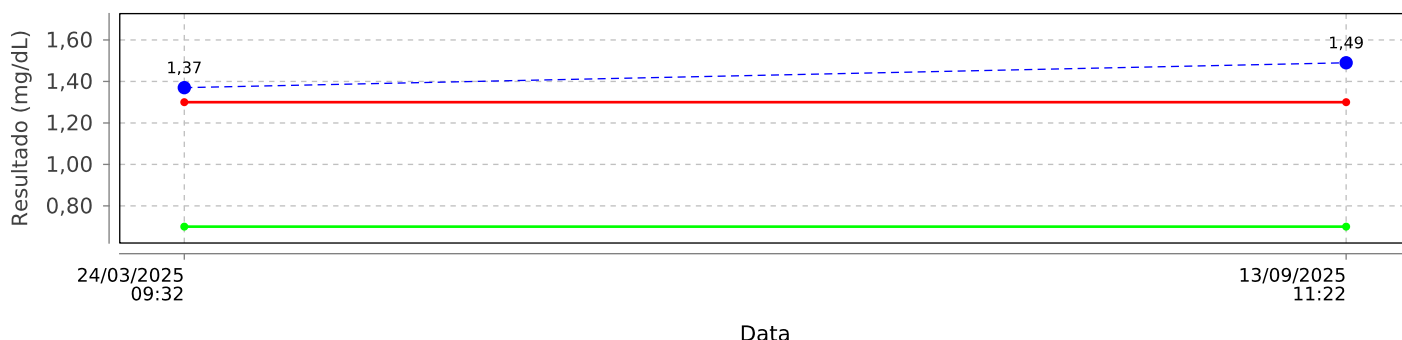
Creatinina

(Material: Soro)

(Método: Colorimétrico Cinético (Jaffé))

Creatinina**1,49** mg/dL

0,70 a 1,30 mg/dL

Gráfico de Histórico***eGFR****66** mL/min/1,73m²Superior a 90 mL/min/1,73m²

Intervalo de referência estabelecido por método indireto em 31.490 indivíduos adultos na Dasa, particionado por sexo.

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023 (vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:

Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb;79(2):268-288.e1.

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:28 BRT)
aeda4febe2608007ae9925445ff7c9c8be6c56be683f6ca4e8826a92817ad209**Ferro**

(Material: Soro)

53 µg/dL

33 a 193 µg/dL

(Método: Colorimétrico)

A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:22 BRT)
f9ccd20c05ae28430318c86928a16155e06cc49b6310f67c0235e5c95a82c99d



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Ferritina

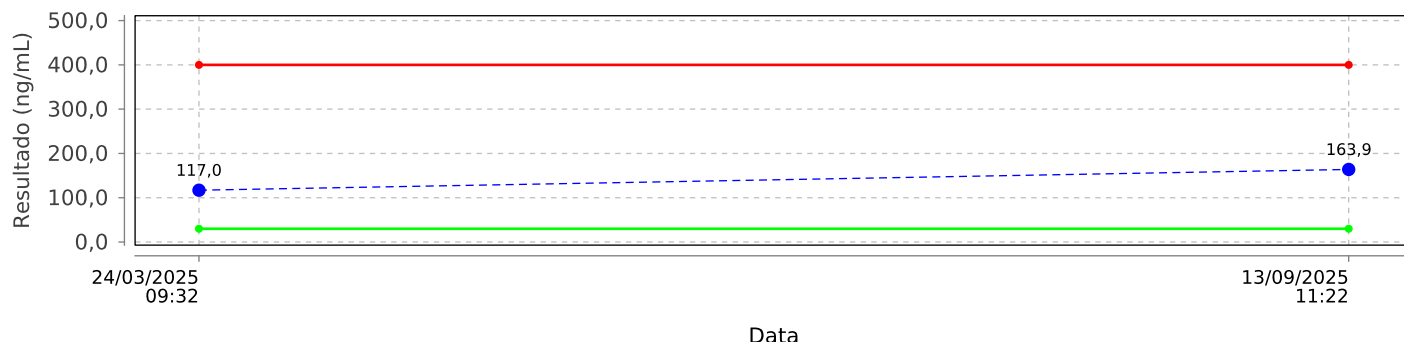
(Material: Soro)

163,9 ng/mL

30,0 a 400,0 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Data

Assinado eletronicamente por Vanessa Fernandes Borloth - CRBM-RJ 64436 (14/09/2025 20:09 BRT)

30010112335b020eadb093059ddf16c9619b52369dcd99322673e63d1b1f3e67

Hormônio

Tireoestimulante Ultra Sensível TSH

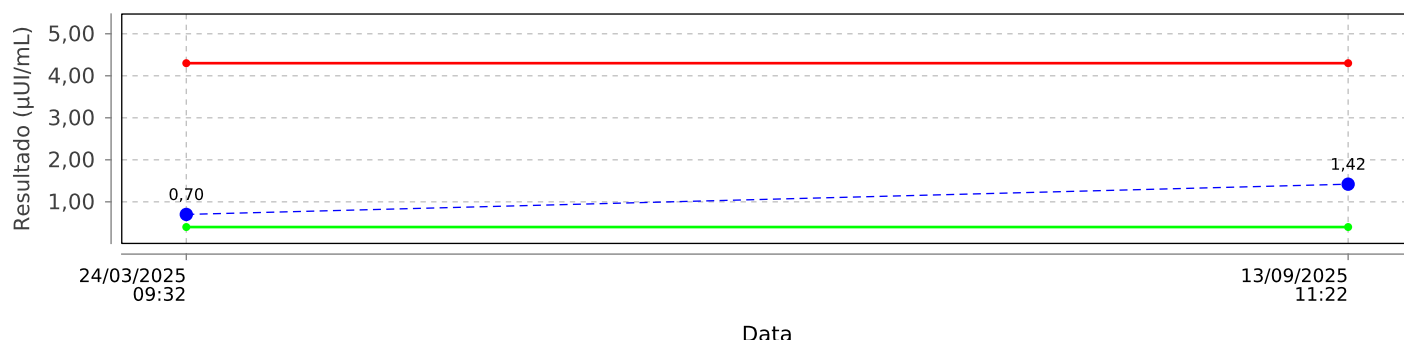
(Material: Soro)

1,42 μ UI/mL

0,40 a 4,30 μ UI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Data

T3 Livre (Triiodotironina Livre)

(Material: Soro)

2,98 pg/mL

2,00 a 4,40 pg/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Nota: A partir de 12/06/2023 houve alteração de valor de referência.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

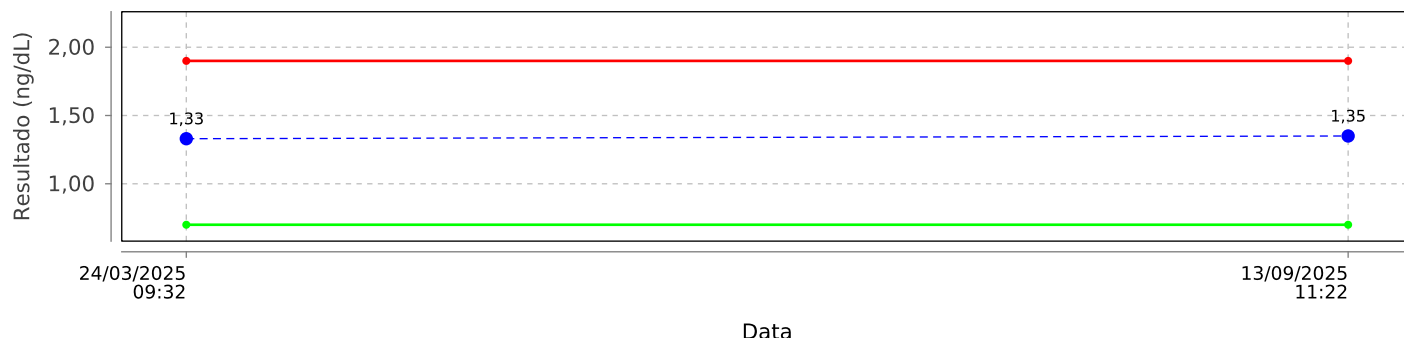
Hora Aproximada: 11:22 BRT

T4 Livre (Tiroxina Livre)**1,35** ng/dL

0,70 a 1,90 ng/dL

(Material: Soro)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

Bibliografia: Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Thyroid Research 2013; 3:13-20.

Assinado eletronicamente por Michel Trindade da Silva CRBIO-RJ 96.439/02-D (14/09/2025 19:02 BRT)

293e2dc795adb087661a2df4c41e0819cea5d61395b089ddd3da3505f308fac7



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Estradiol

(Material: Soro)

42,0 pg/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

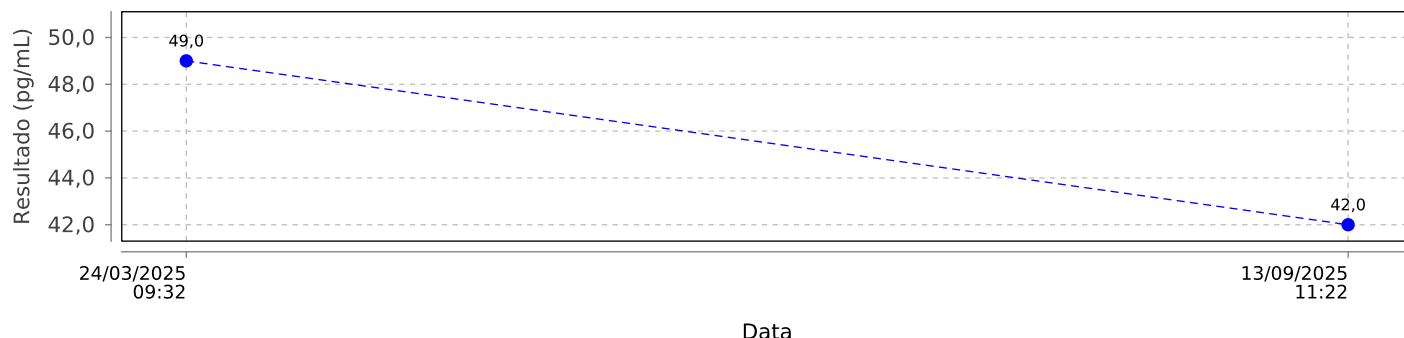


Tabela de Referência - Estradiol

Feminino < 10 anos: Inferior a 5,0 pg/mL
Feminino 10 a 14 anos: até 68,1
Feminino 14 a 18 anos: 14,6 a 249,0
Feminino 19 anos +:
Fase Folicular: 30,9 a 90,4
Fase Ovulatória: 60,4 a 533,0
Fase Lútea: 60,4 a 232,0
Pós-menopausa: até 138,0

Mulheres Grávidas
1º Trimestre: 154,0 a 3243,0 pg/mL
2º Trimestre: 1561,0 a 21280,0
3º Trimestre: 8525,0 a Superior a 30000,0

Masculino < 10 anos : Inferior a 5,0 pg/mL
Masculino 10 a 18 anos: até 36,5
Masculino 19 anos +: 11,3 a 43,2

FSH - Hormônio

Folículo Estimulante

(Material: Soro)

2,4 mUI/mL

Pré Púberes: Até 3,3 mUI/mL

Adultos: 1,5 a 12,4 mUI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



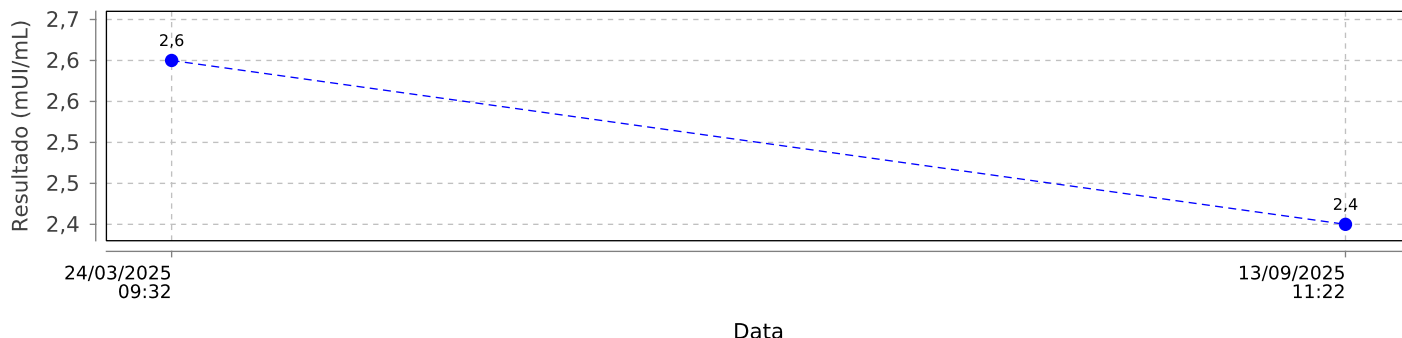
Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT



SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)

(Material: Soro)

55,2 nmol/L

18,3 a 54,1 nmol/L

(Método: Eletroquimioluminescência)

Testosterona Total

(Material: Soro)

809,0 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

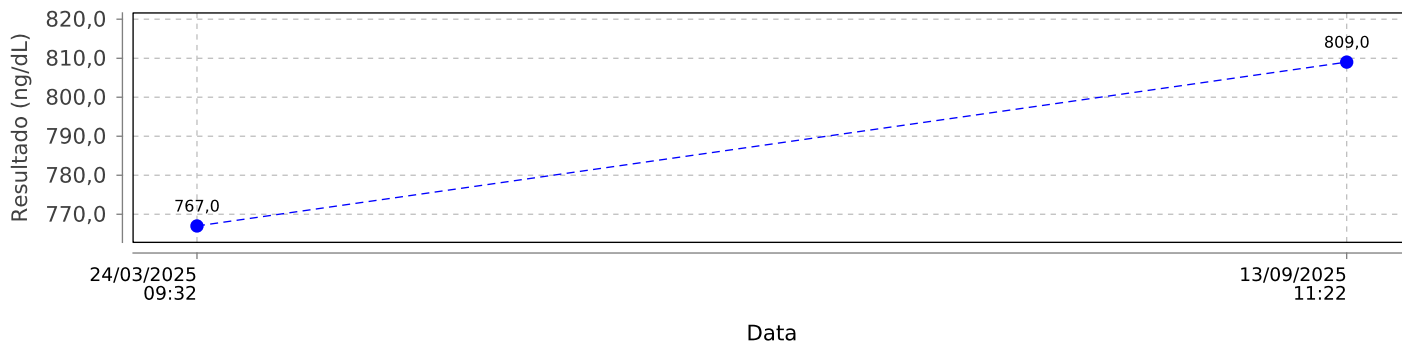


Tabela de Referência - Testosterona Total

Não existem valores de referência pré-definidos para crianças menores de 2 anos.

Feminino
2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 10,4 ng/dL
13 a 18 anos: 2,5 a 23,7 ng/dL
18 a 20 anos: 4,6 a 38,0 ng/dL
20 a 50 anos: 8,4 a 48,1 ng/dL
+50 anos: 2,9 a 40,8 ng/dL

Masculino

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 432,0 ng/dL
13 a 18 anos: 65,0 a 778,0 ng/dL
18 a 20 anos: 188,0 a 882,0 ng/dL
20 a 50 anos: 249,0 a 836,0 ng/dL
+50 anos: 193,0 a 740,0 ng/dL

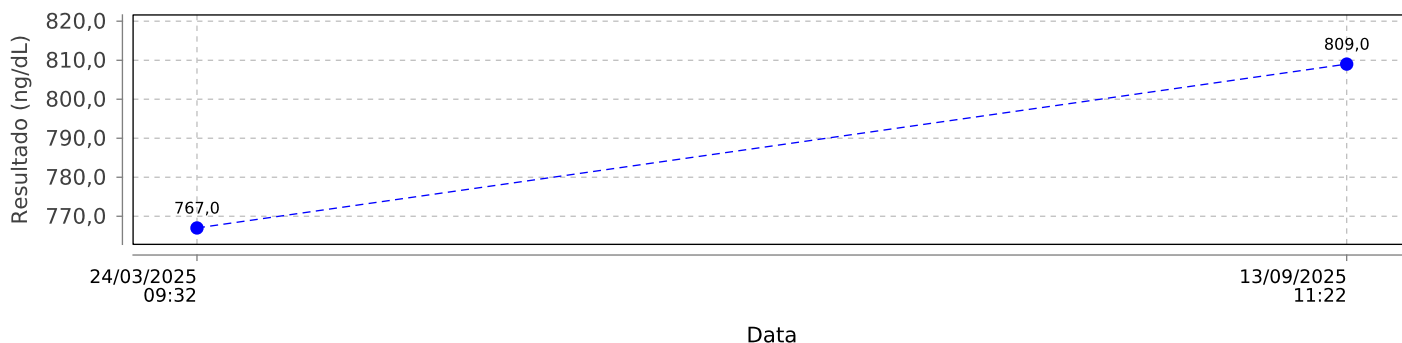
Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

(Material: Soro)

Testosterona Total**809,0** ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico**Tabela de Referência - Testosterona Total**

Não existem valores de referência pré-definidos para crianças menores de 2 anos.

Feminino

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 10,4 ng/dL
13 a 18 anos: 2,5 a 23,7 ng/dL
18 a 20 anos: 4,6 a 38,0 ng/dL
20 a 50 anos: 8,4 a 48,1 ng/dL
+50 anos: 2,9 a 40,8 ng/dL

Masculino

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 432,0 ng/dL
13 a 18 anos: 65,0 a 778,0 ng/dL
18 a 20 anos: 188,0 a 882,0 ng/dL
20 a 50 anos: 249,0 a 836,0 ng/dL
+50 anos: 193,0 a 740,0 ng/dL

**SHBG (Globulina
Transportadora de
Hormônios Sexuais)****55,2** nmol/L

18,3 a 54,1 nmol/L

(Método: Eletroquimioluminescência)

Data da Geração: 23/09/2025 19:03:52
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 52-0105890-8

Laboratório registrado no CRM/RJ: Sob o número 0111212-0

7700.0173.1542
PG 22 de 28

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Testosterona Livre Calculada**13,19** ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Mulheres
Pré Púbere: Sem valor de referência definido
Fase Folicular: 0,18 a 1,68 ng/dL
Meio do Ciclo: 0,30 a 2,34 ng/dL
Fase Lútea: 0,17 a 1,87 ng/dL
Pós Menopausa: 0,19 a 2,06 ng/dL

Homens
Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido
17 a 40 anos: 3,4 a 24,6 ng/dL
41 a 60 anos: 2,67 a 18,3 ng/dL
Acima de 60 anos: 1,86 a 19,0 ng/dL

Testosterona Biodisponível**309,2** ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Homens
Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.
17 a 40 anos: 82,0 a 626,0
41 a 60 anos: 58,0 a 436,0
Acima de 60 anos: 43,0 a 424,0

Mulheres
Pré púberes: Sem valor de referência definido.
Fase folicular: 4,4 a 39,0
Meio do ciclo: 7,1 a 55,0
Fase lútea: 4,1 a 44,0
Pós menopausa: 4,4 a 48,0

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

7700.0173.1542 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Referências bibliográficas:

- (1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672
- (2) Milller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparison of methods J. Clin. Endocrinol. Metab. 89(2). 525-533.
- (3) Giton et al. 2006 Serum Bioavailable Testosterone: Assayed or Calculated ? Clin. Chem, 52:3 474-481.
- (4) Rosner William et al. 2007 Utility, Limitations and Pitfalls in Measuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement? J. Clin. Endocrinol. Metabol 92(2) 405-413.

Assinado eletronicamente por Vanessa Fernandes Borloth - CRBM-RJ 64436 (14/09/2025 20:08 BRT)

4af5907a0eb525e914ab01ceaa03157a471d8ae36fe918d6e5ed3660b9d6f162

Zinco Sanguineo

(Material: Soro)

63,03 µg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama)

Resultado tecnicamente validado em conformidade com o controle de qualidade.

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Níveis de zinco sérico são afetados por fatores fisiológicos, patológicos e medicamentos. Baixos níveis podem indicar má absorção, perdas intestinais, hipoalbuminemia, uso de esteroides, gravidez ou infecção.

Tabela de Referência - Zinco Sanguineo

70,0 a 120, µg/dL (Carência: abaixo de 30 µg/dL)
Até 170,0 µg/dL (Exposição ocupacional)

Assinado eletronicamente por Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469 (17/09/2025 18:09 BRT)

269ce5f1cb8cee73e6837e1c4bc387e62dcb94dfcfaa0ed6279ccbb264b6b6

Dihidrotestosterona (DHT)

(Material: Soro)

402,0 pg/mL

Feminino pré menopausa: Até 596 pg/mL

Feminino pós menopausa: Até 431 pg/mL

Masculino: De 143 a 842 pg/mL

(Método: Ensaio Imunoenzimático)

A metodologia de Imunoensaio possui uma baixa especificidade em algumas situações clínicas. Em caso de discordância clínica-laboratorial, para a maior acurácia da análise, sugerimos a dosagem por Espectrometria de Massas.

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 18:19 BRT)

73c58c44821540ea80eba713c36189c043936178935a70c2439737d31c1bf409

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

**Transaminase oxalacética - TGO
(Aspartato amino transferase)**

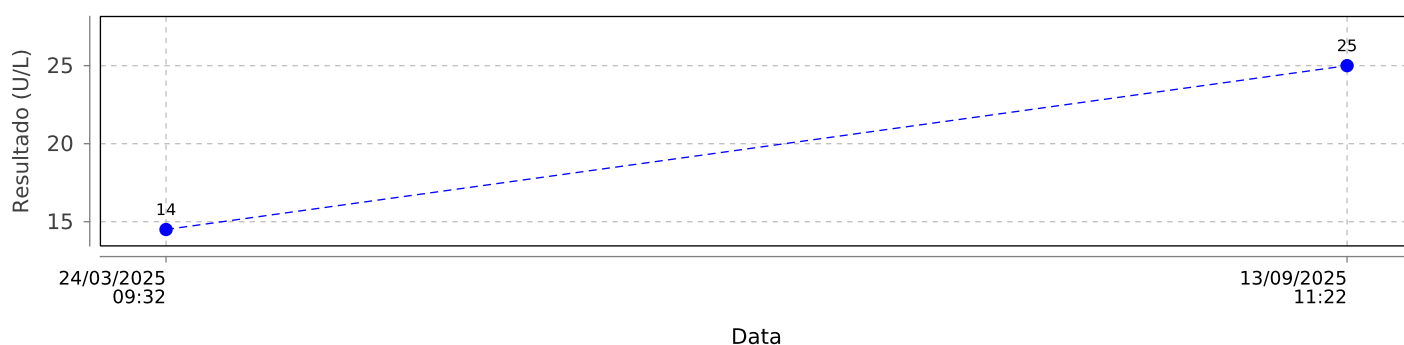
(Material: Soro)

25 U/L

Inferior ou igual 40 U/L

(Método: Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico



**Transaminase pirúvica - TGP
(Alanina amino transferase)**

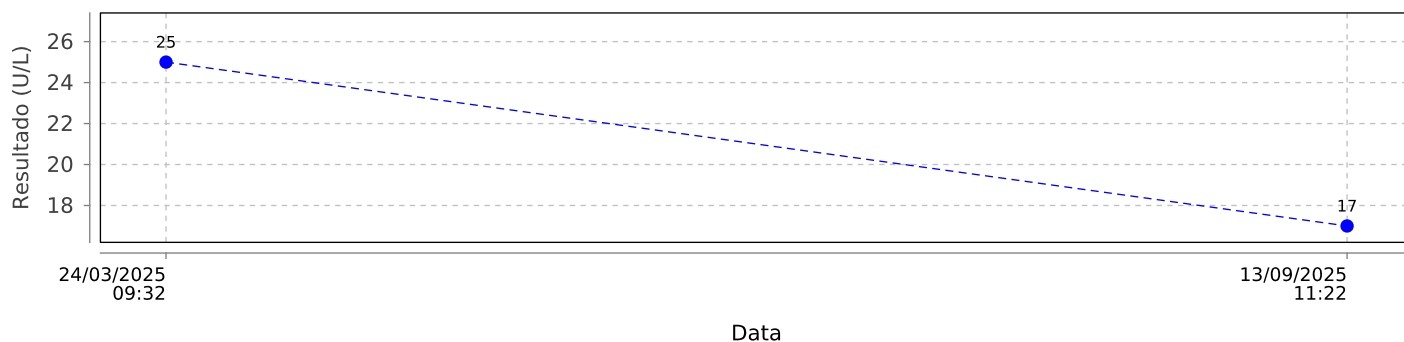
(Material: Soro)

17 U/L

Inferior ou igual a 41 U/L

(Método: Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico



**Gama-Glutamil
Transferase**

(Material: Soro)

28 U/L

Inferior a 60 U/L

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico

7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



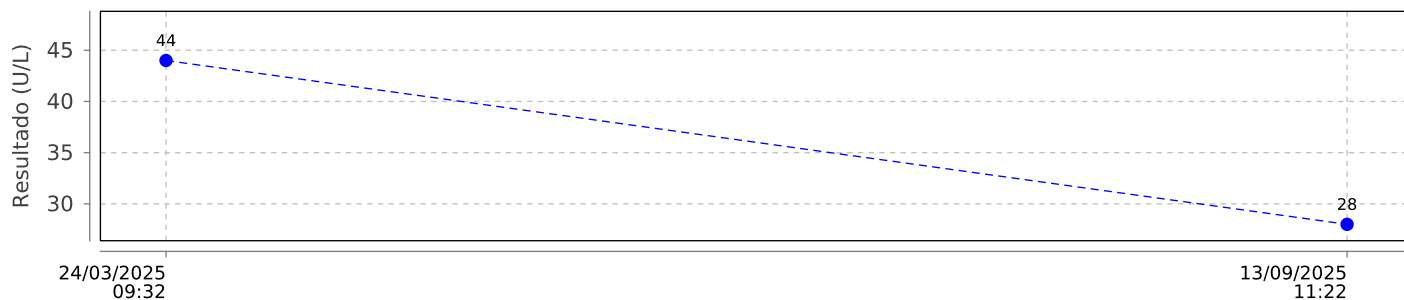
Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT



Data

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:16 BRT)

a0f861d93d06cdb765638f584cf0d2a1c26f6c0923a3d98d9e22d3ac0c62518f

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304



Coordenador: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Amilase

(Material: Soro)

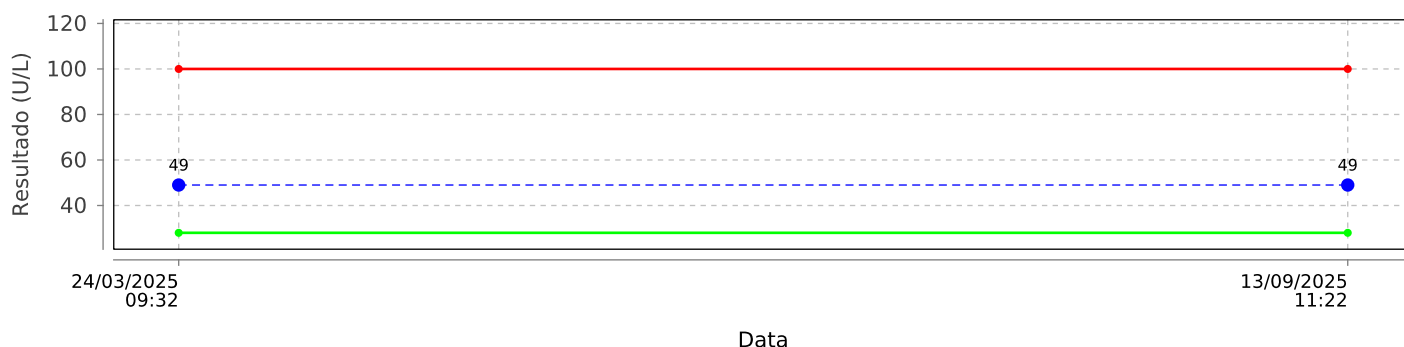
49 U/L

28 a 100

U/L

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Referência Bibliográfica:
Bula

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 16:47 BRT)
b7035768449c6e5f44f74e66d978c847f8fea1d385375775d825d7b447da1ba7

Lipase

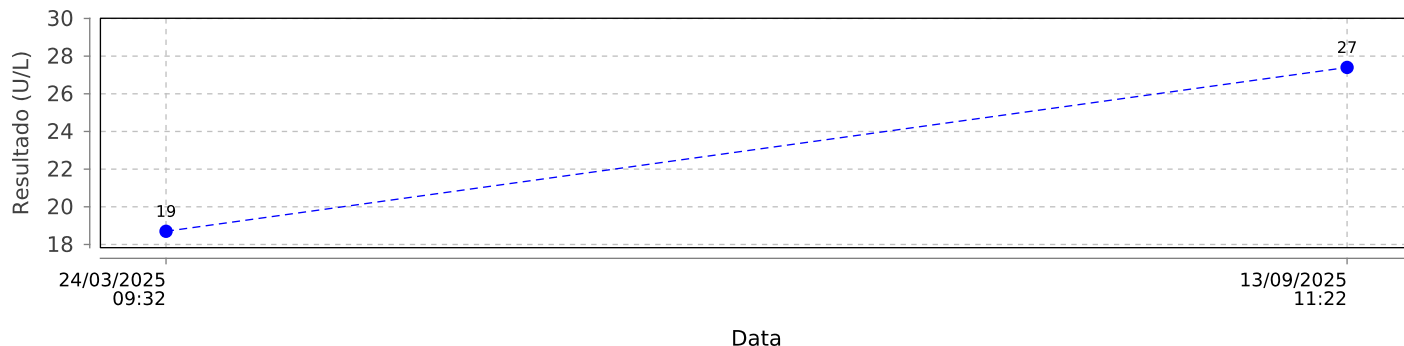
(Material: Soro)

27 U/L

13 a 60 U/L

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Data

Assinado eletronicamente por Raquel Mota Helouani - CRBio 121983/02-P (14/09/2025 17:22 BRT)
933753c114740df60760fce5ece11234d801387f6df462f1f7a4c454d0b5ff9e
Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Sheila Vasques Leandro

Coordenador: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0173.1542 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Dr(a) Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (26 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 13/09/2025

Hora Aproximada: 11:22 BRT

Hormônio Luteinizante (LH)

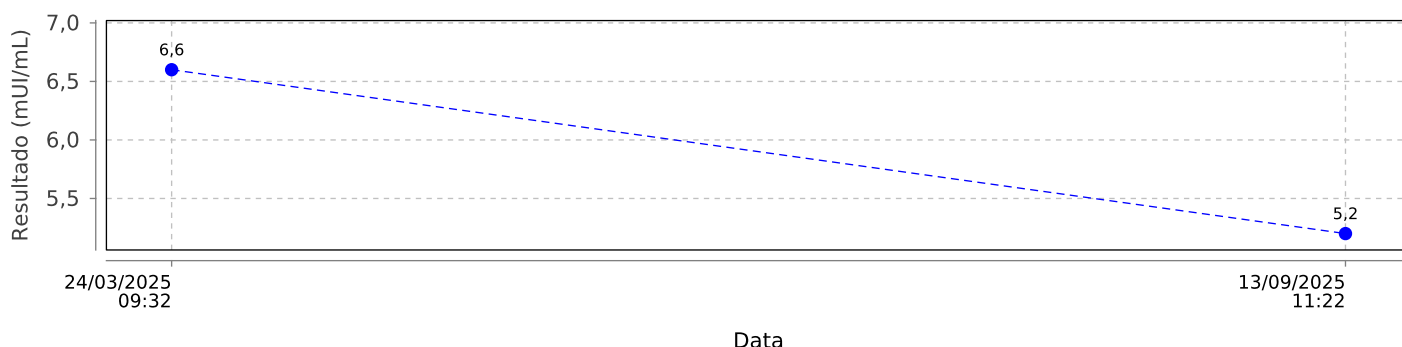
(Material: Soro)

5,2 mUI/mL

Adultos: 1,7 a 8,6 mUI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Vanessa Fernandes Borloth - CRBM-RJ 64436 (14/09/2025 20:08 BRT)
c9d79f90421d6c6489c9593cdd902d7ae202590d358bf915d5a0a7797d7ea8ff

Locais de execução dos exames:

- DASA - Rua Xavier Pinheiro, 439 Quadra 29 - Pq. Duque de Caxias CNES:7402074 - Duque de Caxias, RJ: Amilase, Colesterol Total, Colesterol não HDL, Creatinina, Dihidrotestosterona (DHT), Estradiol, FSH - Hormônio Folículo Estimulante, Ferritina, Ferro, Gama-Glutamil Transferase, Glicose, HDL - Colesterol, Hormônio Luteinizante (LH), Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH, Insulina com Índice HOMA, LDL-Colesterol, Lipase, Potássio, SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais), Sódio, T3 Livre (Triiodotironina Livre), T4 Livre (Tiroxina Livre), Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Testosterona Total, Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Triglicérides, Uréia, VLDL - Colesterol - Cálculo - Martin, Zinco Sanguíneo, Ácido Úrico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.